

ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΕΥΦΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ

- Όλες οι ταχυαρρυθμίες που προέρχονται άνωθεν των κοιλιών, συμπεριλαμβανομένων των κόλπων και του κολποκοιλιακού κόμβου, ομαδοποιούνται ως υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (SVT). Έτσι, παραδείγματα SVT περιλαμβάνουν: τον κολπικό περυγισμό, την κολπική μαρμαρυγή (A-Fib), την κολποκοιλιακή κομβική ταχυκαρδία επανεισόδου (AVNRT) γνωστή επίσης κι ως παροξυσμική υπερκοιλιακή ταχυκαρδία (PSVT), την κολποκοιλιακή ταχυκαρδία επανεισόδου (AVRT) και την πολυεστιακή κολπική ταχυκαρδία (MAT).
- Συστήνεται η αποφυγή χορήγησης επανειλημμένων δόσεων αντιαρρυθμικού ή/και χρήση συνδυασμών αντιαρρυθμικών φαρμάκων. Η χορήγηση πολλαπλών αντιαρρυθμικών φαρμάκων ή η υψηλή δοσολογία ενός μεμονωμένου αντιαρρυθμικού φαρμάκου, δυνητικά, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή καταστολή του μυοκαρδίου και βαριά υπόταση ($MAP < 60 \text{ mmHg}$), με περαιτέρω εκτροπή του καρδιακού ρυθμού.
- Τα αντιαρρυθμικά φάρμακα μπορούν να διακόψουν τους έκτοπους ρυθμούς, αλλά και να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν προϋπάρχοντες τέτοιους ρυθμούς («προαρρυθμική» δράση). Χορηγούνται δηλαδή για να διακόψουν έκτοπους ρυθμούς με κοιλιακή ή υπερκοιλιακή προέλευση ή για να προλάβουν την εμφάνισή τους, υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν ελλοχεύει κίνδυνος για εμφάνιση πιο σοβαρών αρρυθμιών από την προαρρυθμική τους δράση (όπως επί ΣΝ/OEM, ΣΚΑ, LBBB, 2^ο ή 3^ο AVB, δομική καρδιοπάθεια κ.ά.).
- Δεν υπάρχουν ακόμα σαφείς βιβλιογραφικές ενδείξεις βελτίωσης των ποσοστών επιβίωσης με τη χρήση αντιαρρυθμικών φαρμάκων, συστηματικά, κατά τη διάρκεια της καρδιακής ανακοπής.
- Κοινή αντένδειξη της χρήσης όλων των αντιαρρυθμικών φαρμάκων είναι ο φλεβοκομβοκολπικός και ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός, εφόσον βέβαια δεν υπάρχει ήδη τοποθετημένος κατάλληλος βηματοδότης, καθώς επίσης αντένδειξη αποτελούν και οι έκτοποι ρυθμοί από διαφυγή (*AV Junctional Escape Rhythm*).
- Η παρουσία έκτοπων κοιλιακών συστολών σε ασθενή με παλαιό έμφραγμα του μυοκαρδίου ή με ιστορικό χρόνιας ισχαιμικής καρδιοπάθειας, αποτελεί αντένδειξη για τη χορήγηση αντιαρρυθμικών φαρμάκων, με εξαίρεση τους β-αποκλειστές και ενδεχομένως την Αμιωδαρόνη (*Angoron*).
- Παρά την ευρεία χρήση της Αδρεναλίνης κατά τη διάρκεια της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και την ύπαρξη μελετών για τη Βαζοπρεσίνη, δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες μελέτες με ομάδα ελέγχου που να επιβεβαιώνουν την ευεργετική επίδραση της αγγειοσύσπασης στην τελική νευρολογική έκβαση μετά από καρδιακή ανακοπή, όταν χορηγείται σε οποιοδήποτε στάδιο της αναζωογόνησης σε ανθρώπους.
- Η Αδρεναλίνη είναι το κύριο συμπαθητικομιμητικό φάρμακο για αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής. Η α-αδρενεργική δράση της προκαλεί συστηματική αγγειοσύσπαση η οποία αυξάνει τη στεφανιαία και εγκεφαλική πίεση αιμάτωσης. Οι β-αδρενεργικές δράσεις της αυξάνουν την κατανάλωση O_2 , προκαλούν έκτοπες κοιλικές αρρυθμίες, καθώς επίσης παροδική υποξαιμία και διαταραχές στη μικροκυκλοφορία. Αν και η χρήση της Αδρεναλίνης σχετίζεται με περισσότερες διαταραχές ρυθμού στο ALS, τόσο στην VF όσο και στην pEA, η βελτίωση της βραχυπρόθεσμης επιβίωσης επέβαλε τη συνέχιση της χρήσης της στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.
- Η Αμιωδαρόνη (amp. *Angoron* 150 mg), συγκριτικά με το placebo ή την Ξυλοκαΐνη, υπερέχει ως προς τη βραχυπρόθεσμη έκβαση – μέχρι την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο – στην ανθεκτική στον απινιδισμό κοιλική μαρμαρυγή (VF). Οι ενδείξεις για τη χορήγηση Αμιωδαρόνης, είναι: η ανθεκτική VF/pVT μετά το 3^ο shock κατά την ΚΑΡΠΑ (CPR), σε δόση 300 mg (2 amp.) διαλυμένα σε 20 ml D₅W ή 20 ml NaCl 0,9% (βλέπε εδάφιο: *Κοιλιακή Μαρμαρυγή*), καθώς και επί ανθεκτικής ή υποτροπιάζουσας VF/pVT, κατά την οποία χορηγείται μία επιπλέον δόση των 150 mg (1 amp.) μετά το 5^ο shock.
- Η Ξυλοκαΐνη (Λιδοκαΐνη 2%) αποτελεί καλή κι αποδεκτή εναλλακτική επιλογή, ελλείψει Αμιωδαρόνης, στη θεραπεία της κοιλικής ταχυκαρδίας (VT), αλλά δεν συγχρηγείται ποτέ με αυτή.
- Στην περίπτωση κοιλικής ταχυκαρδίας (VT) λόγω τοξικότητας εκ Διγοξίνης, φάρμακα εκλογής για την άμεση ανάταξη, είναι η Φαιντοϊνη ή η Λιδοκαΐνη. Αντενδείκνυται η χρήση Αμιωδαρόνης, β-αναστολέων και αναστολέων των διαύλων ασβεστίου (π.χ. Διλτιαζέμη, Βεραπαμίλη).
- Η χορήγηση Μαγνησίου ($MgSO_4$) δεν αυξάνει την επιβίωση και δε συστήνεται χρήση ρουτίνας κατά την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, παρά μόνον επί υποψίας torsades de pointes, σε δόση 2 gr, (iv) εφάπαξ κι εφόσον υπάρχει υποψία ή διάγνωση υπομαγνησιαιμίας (π.χ. ασθενής που λαμβάνει διουρητικά).
- Τα Διττανθρακικά ($NaHCO_3$) χορηγούνται επί σοβαρής υπερκαλιαιμίας ή επί δηλητηρίασης με τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, συνεκτιμώντας πάντοτε τα αέρια αίματος και τη βαρύτητα ή τη διάρκεια της οξέωσης. Δε φάνηκε όμως να αυξάνουν την επιβίωση στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.
- Η Βεραπαμίλη μπορεί να αυξήσει τη δράση ουσίων, όπως: διγοξίνη, θεοφυλλίνη, κλονιδίνη, ιβαμπραδίνη, καρβαμαζεπίνη, μη εκπολωτικά μυοχαλαρωτικά (π.χ. *ροκουρόνιο*, *cis-ατρακούριο*), φαιντανύλη και λίθιο. Αντιθέτως, ουσίες όπως: βαρβιτουρικά, ριφαμπικίνη, βιταμίνη D, μειώνουν τα επίπεδα της βεραπαμίλης.
- Η χορήγηση των αντιαρρυθμικών φαρμάκων, γίνεται πάντοτε υπό συνεχή ΗΚΓφικό έλεγχο (monitoring).